



GUIA PARA PACIENTES

Dor no pescoço do celular e do computador

o que a ciência diz sobre postura e o que tem respaldo para ajudar

A verdade sobre o "pescoço de celular", 3 exercícios estudados, um plano de 7 dias e os sinais que não dá para esperar.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **PESCOCO**

Para quem é:

Para quem sente dor no pescoço e na parte de cima dos ombros depois de horas no celular, no computador ou estudando, **sem queda nem batida e sem nenhum dos sinais de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem tem dor que **desce pelo braço** com formigamento, dormência ou fraqueza na mão. Nesse caso, a avaliação vem antes dos exercícios.
- Quem operou a coluna cervical, tem artrite reumatoide, osteoporose avançada ou está grávida: converse com seu médico antes de fazer os movimentos deste guia.

O que você vai precisar:

- Uma cadeira com encosto.
- Uma toalha pequena.
- Um elástico de exercício de resistência leve (ou uma garrafa de água).
- Este guia e uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Desconforto leve, que passa logo depois do exercício: **aceitável.**
Dor que aumenta, formigamento ou choque descendo pelo braço, tontura ou visão alterada: **pare** e procure avaliação.

A maioria das dores no pescoço não é grave. Mas a minoria que é tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se você tiver:

- Dor no pescoço depois de **queda, acidente, mergulho em água rasa ou pancada na cabeça** [13].
- Dor de cabeça ou na nuca **súbita, muito forte e diferente de tudo** que já sentiu, principalmente com **tontura, visão dupla, fala enrolada, dificuldade para engolir, desequilíbrio ou pálpebra caída**. Pode ser lesão de uma artéria do pescoço: rara, mas urgente [15][16].
- **Fraqueza que está piorando** em braço ou perna, ou perda do controle da urina ou das fezes [13][14].
- Dor no pescoço ou na mandíbula junto com **aperto no peito, falta de ar ou suor frio**. Pode ser o coração (orientação clínica geral).

Procure avaliação em poucos dias se:

- Suas **mãos ficaram "desajeitadas"**: dificuldade nova para abotoar a camisa, escrever, usar chaves ou o celular, objetos caindo da mão, ou se você **anda desequilibrado**. Pode ser compressão da medula no pescoço, que muitas vezes é reconhecida tarde [14].
- A dor **desce pelo braço** com formigamento ou dormência [1].
- Você tem **febre, perda de peso sem querer, câncer prévio** ou dor que **piora à noite e não alivia em nenhuma posição** [13].

Uma observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, quer dizer doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes** [13].

Na maioria das vezes, não há lesão

Na maior parte das dores no pescoço, não existe uma peça "quebrada" que explique a dor. É a chamada dor cervical inespecífica [1]. O exame de imagem também confunde: em 1.211 pessoas **sem dor**, quase 9 em cada 10 tinham disco "abaulado" na ressonância, inclusive a maioria das pessoas de 20 e poucos anos [12].

O que esperar

A dor costuma melhorar bastante nas primeiras 6 semanas. Sendo honesto, muita gente ainda tem algum grau de dor depois de 1 ano [3]. Por isso vale cuidar do pescoço com hábitos, e não só "esperar passar".

E a postura do celular?

A internet diz que olhar para baixo "destrói" a coluna. A ciência é bem mais modesta:

- Num estudo brasileiro com 582 adultos, o ângulo do pescoço ao usar o celular **não teve relação** com ter dor, nem com a frequência ou a força da dor [5].
- Uma revisão encontrou a cabeça um pouco mais projetada para a frente em adultos com dor, mas não em adolescentes. Esses estudos não mostram o que veio primeiro, e a idade interfere na análise [4].

Resumo honesto: a postura, sozinha, explica pouco. No consultório, o que mais pesa costuma ser passar horas na mesma posição (opinião clínica). Se uma posição incomoda, mude. A melhor postura costuma ser a próxima.

Primeiro, a verdade: os estudos que mudaram cadeira, mesa e tela no trabalho têm qualidade baixa e não provam que isso reduza a dor no pescoço [6][7]. Ajuste o ambiente por **conforto**, não como tratamento. O que tem mais respaldo é o exercício (Páginas 6 e 7) [6].

Pausas

A cada 30 a 40 minutos de tela, faça 1 a 2 minutos de pausa:

- Levante e caminhe um pouco.
- Olhe para longe.
- Gire os ombros para trás, 5 vezes.
- Faça 5 repetições do Exercício 1 (Página 6).

Esse intervalo é uma orientação prática, não um número estudado.

Ajustes de conforto (opinião clínica)

- **Tela:** o topo na altura dos olhos ou um pouco abaixo, a cerca de um braço de distância.
- **Notebook por horas:** apoie o aparelho mais alto e use teclado e mouse separados.
- **Celular:** traga o aparelho um pouco mais para cima e apoie os cotovelos. Para textos longos, prefira o computador ou a mensagem de voz.
- **Cadeira:** pés no chão, costas e antebraços apoiados.
- **Visão:** se você projeta a cabeça para enxergar, vale revisar os óculos.
- **Alterne:** sentado, em pé, ligação caminhando. Variar importa mais do que achar a posição "perfeita".

Antes de começar: na dor no pescoço que persiste, o exercício é o tratamento com melhor respaldo, principalmente o fortalecimento do pescoço, dos ombros e da região das escápulas. A evidência é moderada, não alta [2][6]. Alongar sozinho parece não mudar a dor [2].

Exercício 1 — Retração cervical ("queixo para trás"), sentado

Como fazer: costas apoiadas, olhando para a frente. Leve o queixo para trás, em linha reta, como se fizesse uma "papada", sem abaixar nem levantar a cabeça. Segure 3 segundos e solte. 10 vezes.

Sensação correta: alongamento leve na nuca, na base do crânio.

Erro comum: abaixar a cabeça em vez de levá-la para trás, ou forçar.

Faz parte dos exercícios de mobilidade e postura da diretriz [1]. Não há prova de que, sozinho, resolva a dor.

Exercício 2 — O "sim" pequeno, deitado (flexores profundos)

Como fazer: barriga para cima, joelhos dobrados, toalha fina dobrada sob a nuca se precisar. Faça um "sim" bem pequeno só com o queixo, deslizando a parte de trás da cabeça no apoio, **sem tirá-la dele**. Segure 10 segundos, respirando normalmente. 10 vezes.

Sensação correta: esforço leve e profundo na frente do pescoço.

Erro comum: levantar a cabeça, prender a respiração ou contrair os músculos da frente que "saltam".

Melhora o controle dos músculos profundos do pescoço; o ganho de força é pequeno [9].

Exercício 3 — Remada com elástico

Como fazer: prenda o elástico em algo firme, na altura do peito (por exemplo, a maçaneta de uma porta fechada, puxando para o lado em que ela não abre). Em pé, segure as pontas com os braços esticados. Puxe os cotovelos para trás, rentes ao corpo, aproximando as escápulas. Volte devagar. 3 séries de 10 a 12.

Sensação correta: trabalho entre as escápulas e atrás dos ombros, com cansaço muscular no fim da série.

Erro comum: encolher os ombros em direção às orelhas, jogar o tronco para trás ou deixar a cabeça ir para a frente.

Sem elástico: faça a remada com uma garrafa de água, um braço de cada vez, apoiando a outra mão numa mesa.

O que diz a pesquisa: em 48 trabalhadoras com dor crônica no pescoço e nos ombros, 10 semanas de fortalecimento específico reduziram a dor bem mais do que pedalar [8]. Revisões confirmam o benefício do fortalecimento, com evidência moderada [2][6].

Frequência (ponto de partida prático)

- Exercícios 1 e 2: 1 a 2 vezes ao dia.
- Exercício 3: 3 vezes por semana, em dias alternados.
- Quando 3 séries de 12 ficarem fáceis, use um elástico mais forte.
- **Constância conta:** nos estudos, quem participou mais teve mais benefício [6].
- **Paciência:** o efeito do fortalecimento costuma aparecer em semanas, não em dias [8].

Sono

Dormir mal e sentir dor costumam andar juntos: um piora o outro (opinião clínica). Horário regular para deitar e acordar ajuda mais do que qualquer acessório.

Travesseiro

Uma revisão de 2021 encontrou redução **pequena** da dor com travesseiros de látex ou de molas em pessoas com dor crônica. Mas o travesseiro **não melhorou a qualidade do sono**, e a altura e o formato parecem pesar mais do que o material [10]. **Não existe travesseiro que cure o pescoço.**

Na prática (opinião clínica):

- **De lado:** um travesseiro que preencha o espaço entre o ombro e a cabeça, com o pescoço alinhado ao resto da coluna.
- **De barriga para cima:** travesseiro mais baixo, que não empurre o queixo contra o peito.
- **De bruços:** o pescoço fica girado por horas. Se der, evite.
- **Celular deitado:** muito tempo com a cabeça dobrada sobre o travesseiro costuma acabar em pescoço travado.

E os remédios?

Este guia não indica remédio nem dose. Quem decide é o seu médico, porque depende da sua saúde e dos remédios que você já usa.

- Os opioides (remédios do grupo da morfina) **não são primeira escolha:** num estudo com dor lombar ou cervical aguda, não aliviaram mais do que o placebo e aumentaram o risco de uso indevido [11].
- Não use remédio de outra pessoa nem repita receita antiga.

Dias 1 e 2 — Começar

- Ajustar tela, cadeira e celular (Página 5).
- Pausas a cada 30 a 40 minutos de tela.
- Exercícios 1 e 2, uma vez ao dia.
- Exercício 3 no Dia 1, com 2 séries leves.

Dias 3 a 5 — Firmar o hábito

- Exercícios 1 e 2, duas vezes ao dia.
- Exercício 3 nos Dias 3 e 5, com 3 séries.
- Caminhada de 20 a 30 minutos. Atividade física geral também ajuda, mas menos do que o fortalecimento [6][8].
- Rever o travesseiro e a posição de dormir (Página 8).

Dias 6 e 7 — Manter e conferir

- Mesma rotina; Exercício 3 no Dia 7.
- **Revisar a Página 3.** Algum sinal novo? Procure avaliação.
- Comparar o Dia 1 com o Dia 7 no rastreador.

7 dias servem para criar o hábito. O ganho do exercício costuma vir em semanas [8].

Rastreador

	Dor ao acordar (0–10)	Dor no fim do dia (0–10)	Pausas feitas (nº)	Exercícios (S/N)	Sono (bom / médio / ruim)	Formigamento no braço? (S/N)
Dia 1						
Dia 2						
Dia 3						
Dia 4						
Dia 5						
Dia 6						
Dia 7						

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Ela diz mais ao médico do que "doeu muito".

1. Caçar a postura perfeita.

Nenhuma postura foi provada como "a certa" [4][5]. Ficar horas travado numa posição "correta" também cansa. Variar é a regra.

2. Só alongar.

Alongar sozinho parece não mudar a dor. O fortalecimento tem mais respaldo [2].

3. Imobilizar o pescoço por conta própria.

As diretrizes orientam voltar às atividades normais e evitar o colar cervical, salvo indicação médica [1].

4. Exigir ressonância sem sinal de alerta.

Alterações como disco "abaulado" são comuns em quem não sente dor [12]. O exame é pedido quando vai mudar a conduta, e isso o médico avalia.

5. "Estalar" o pescoço sozinho ou pedir a alguém que gire com força.

Manobra no pescoço é procedimento, feito por profissional habilitado depois de avaliação. Lesão de artéria do pescoço é rara, mas existe [15] [16].

6. Se automedicar ou empilhar remédios.

Mais remédio não é mais alívio, e o risco aumenta (Página 8).

Procure avaliação médica se:

- A dor **não melhora de forma clara em 2 a 3 semanas**, ou **dura mais de 6 semanas**.
- A dor **desce pelo braço**, ou surge **formigamento, dormência ou fraqueza** na mão.
- Aparece **dor de cabeça que começa na nuca** e está ficando frequente.
- A dor **está piorando** em vez de melhorar.
- As crises **se repetem** e atrapalham o trabalho, o estudo ou o sono.
- **A qualquer momento**: surgir algum sinal da Página 3.

Os prazos acima são de bom senso clínico, coerentes com o que se sabe sobre a evolução da dor no pescoço [3]. Não são uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

Na consulta, a avaliação é feita **com exame físico**: história, movimentos do pescoço e dos ombros, força, sensibilidade, reflexos e marcha. Só depois disso se decide se há necessidade de exame e qual é o tratamento. Quando o caso pede um especialista em coluna, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, Sparks C, Robertson EK. **Neck Pain: Revision 2017.** J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):A1-A83. doi:10.2519/jospt.2017.0302. PMID: 28666405.
2. Gross A, Kay TM, Paquin JP, et al. **Exercises for mechanical neck disorders.** Cochrane Database Syst Rev. 2015;1:CD004250. doi:10.1002/14651858.CD004250.pub5. PMID: 25629215.
3. Hush JM, Lin CC, Michaleff ZA, Verhagen A, Refshauge KM. **Prognosis of acute idiopathic neck pain is poor: a systematic review and meta-analysis.** Arch Phys Med Rehabil. 2011;92(5):824-829. doi:10.1016/j.apmr.2010.12.025. PMID: 21458776.
4. Mahmoud NF, Hassan KA, Abdelmajeed SF, Moustafa IM, Silva AG. **The relationship between forward head posture and neck pain: a systematic review and meta-analysis.** Curr Rev Musculoskelet Med. 2019;12(4):562-577. doi:10.1007/s12178-019-09594-y. PMID: 31773477.
5. Correia IMT, Ferreira AS, Fernandez J, Reis FJJ, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. **Association between text neck and neck pain in adults.** Spine (Phila Pa 1976). 2021;46(9):571-578. doi:10.1097/BRS.0000000000003854. PMID: 33290371.
6. Chen X, Coombes BK, Sjøgaard G, Jun D, O'Leary S, Johnston V. **Workplace-based interventions for neck pain in office workers: systematic review and meta-analysis.** Phys Ther. 2018;98(1):40-62. doi:10.1093/ptj/pzx101. PMID: 29088401.
7. Aas RW, Tuntland H, Holte KA, Røe C, Lund T, Marklund S, Møller A. **Workplace interventions for neck pain in workers.** Cochrane Database Syst Rev. 2011;(4):CD008160. doi:10.1002/14651858.CD008160.pub2. PMID: 21491405.
8. Andersen LL, Kjaer M, Sjøgaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjøgaard G. **Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain.** Arthritis Rheum. 2008;59(1):84-91. doi:10.1002/art.23256. PMID: 18163419.
9. Blomgren J, Strandell E, Jull G, Vikman I, Röijezon U. **Effects of deep cervical flexor training on impaired physiological functions associated with chronic neck pain: a systematic review.** BMC Musculoskelet Disord. 2018;19(1):415. doi:10.1186/s12891-018-2324-z. PMID: 30486819.
10. Chun-Yiu JP, Man-Ha ST, Chak-Lun AF. **The effects of pillow designs on neck pain, waking symptoms, neck disability, sleep quality and spinal alignment in adults: a systematic review and meta-analysis.** Clin Biomech (Bristol). 2021;85:105353. doi:10.1016/j.clinbiomech.2021.105353. PMID: 33895703.
11. Jones CMP, Day RO, Koes BW, et al; OPAL Investigators Coordinators. **Opioid analgesia for acute low back pain and neck pain (the OPAL trial): a randomised placebo-controlled trial.** Lancet. 2023;402(10398):304-312. doi:10.1016/S0140-6736(23)00404-X. PMID: 37392748.
12. Nakashima H, Yukawa Y, Suda K, Yamagata M, Ueta T, Kato F. **Abnormal findings on magnetic resonance images of the cervical spines in 1211 asymptomatic subjects.** Spine (Phila Pa 1976). 2015;40(6):392-398. doi:10.1097/BRS.0000000000000775. PMID: 25584950.
13. Finucane LM, Downie A, Mercer C, et al. **International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies.** J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):350-372. doi:10.2519/jospt.2020.9971. PMID: 32438853.
14. Davies BM, Mowforth OD, Smith EK, Kotter MR. **Degenerative cervical myelopathy.** BMJ. 2018;360:k186. doi:10.1136/bmj.k186. PMID: 29472200.
15. Arning C, Hanke-Arning K, Eckert B. **The clinical features of dissection of the cervical brain-supplying arteries.** Dtsch Arztebl Int. 2022;119(35-36):581-587. doi:10.3238/arztebl.m2022.0238. PMID: 35734920.
16. Rushton A, Carlesso LC, Flynn T, Hing WA, et al. **International Framework for Examination of the Cervical Region for Potential of Vascular Pathologies of the Neck Prior to Musculoskeletal Intervention: International IFOMPT Cervical Framework.** J Orthop Sports Phys Ther. 2023;53(1):7-22. doi:10.2519/jospt.2022.11147. PMID: 36099171.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

